

Fecha Última Actualización: 12-09-2024 23:24:37

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Grace Dyan Martinez Otiniano
Edad : 29a 7m 13d
Dirección : Quilan 3553 Pedro Lira 33 3553

Rut : 25.209.207-2
Fecha Nacto: 30/01/1995
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1709902
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 9933 8677

N° Epicrisis
413495

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 10/09/2024 17:28

Días Estadía : 2

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 12/09/2024 23:09

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Falla respiratoria aguda

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

FI CASR 10/09/24
FI UPC 11/09/24

APACHE II (12/09) 31 puntos
SOFA (12/09) 16 puntos.

DIAGNÓSTICOS ACTUALES

- 1) Shock séptico refractario.
 - a) Foco de neumopatía en llingula.
 - b) Bacteremia por E. coli.
 - c) Panel viral (+) Metapneumovirus
 - d) PCR Viral CAET (+) Rhinovirus.
 - e) HFAV Fi 11/09 22:30
- 2) NFAR de alto riesgo
- 3) FOM.
 - a) Coagulopatía.
 - b) Insf. Respiratoria.
 - c) Hipoglicemia
- 4) Antecedentes: LLA Phi (+), TPH marzo 2024.

ANTECEDENTES.

AM: Leucemia linfoblástica aguda Phi (+), CD20 (+).

Aqx: TPH alogénico 26/03/2024, tonsilectomía palatina, cesárea

Fármacos: Ciclosporina 50 mg cada 12 horas VO, Eltrombopag 150 mg cada 24 horas VO, Cotrimoxazol forte 1 comp. VO martes y jueves, Aciclovir 800 mg cada 8 horas VO, Ácido fólico 10 mg cada 24 h VO, ondansetrón 8 mg cada 8 horas SOS, ácido ursodeoxicólico 250 mg cada 12h VO, Clonazepam 0,5 mg cada 24 horas VO.

Hábitos: TBQ (-), OH ocasional, Drogas: -

Alergias: -

Fecha Epicrisis : 12/09/2024 23:24

Página 1 de 4

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:30

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 12-09-2024 23:24:37

Página 2 de 4

HISTORIA ACTUAL.

Paciente con antecedente de hospitalización reciente en unidad de hemato-oncología de Hospital del Salvador desde el 08/08/24 al 26/08/24 por sepsis de foco pulmonar (neumonía lingular multifactorial izquierda) por neumococo, VRS, rinovirus, E. coli y E. faecium, asociado a reactivación de VEB, VHH6, recibiendo tratamiento ATB con imipenem por 6 días, posteriormente ajustado a Meropenem y Amikacina, completando 10 días de tratamiento ATB EV, indicando completar 7 días post alta con levofloxacin VO. Recibió una dosis de rituximab en contexto de reactivación de VEB.

Consulta en SU CASR el 10/09 por cuadro de 2 semanas de síntomas respiratorios altos, vómitos, diarrea; asociando el día previo a consultar fiebre hasta 40°C y tos expectorativa.

A su ingreso a CASR presenta SV FC 130 LPM, PA 61/47, PAM 51, T 37.1°C. Se describe a su ingreso hipotensa, con perfusión límite, abdomen sensible difuso a la palpación. Exámenes de ingreso destaca ácido láctico de 16.4, creatinina 1.04, BUN 21.4, PCR 292, GB 102, GSV pH 7.429, Pco2 27.8, HCO3 18. Inicia soporte hemodinámico con volemicización con ringer lactato, BIC de noradrenalina e inicia terapia ATB empírica con tazonom y vancomicina.

Evoluciona con mayor compromiso hemodinámico, lactato al alza, por lo que el 11/09 se inicia segundo vasoactivo con adrenalina, describiéndose lograr PAM de 65 mmHg con NAD 0.3 mcg/kg/min y adrenalina 0.15 nmcg/min. Se realiza IOT mediante SRI, descrita sin incidentes, laringoscopia Cormack 1, colocando TOT 8.0 a 21 cm.

Ingresa a UPC a las 14:30 del 11/09. SV a su ingreso PA 99/36, PAM 57, FR 139, T 38.2°C. A su ingreso llene capilar conservado, sin mottling. Por compromiso hemodinámico se inicia vasopresina y se decide iniciar HFAV, comenzando el 11/09 a las 22:00.

Por compromiso ventilatorio asociado a PaFI en 98 se decide pronar a las 00:00 del 12/09.

Hemocultivos tomados a su ingreso en SU positivos a E. coli.

EVOLUCIÓN POR SISTEMAS.

Hemodinámico: paciente con hipotensión persistente con patrón vasoplejico, con compromiso hemodinámico persistente y requerimiento de vasoactivos al alza, llegando a noradrenalina 1 mcg/kg/min, adrenalina 0.14 mcg/kg/min, vasopresina 0.07 U/min, pese a lo cual mantiene inestabilidad hemodinámica, llene capilar prolongado y progresión de mottling. Tras inicio de HFAV sin mejora hemodinámica o disminución de lactato.

Ventilatorio: con requerimiento de VMI, FiO2 alza, actualmente 85%; por PaFI < 100 se decide pronar, sin mayor respuesta.

Infectológico: hemocultivos tomados en SU positivo a E. coli resistente a ampicilina/sulbactam, cefazolina, Ciprofloxacino, tazonom y cotrimoxazol. TC de tórax con neumonía lingular, cuadro similar a lo descrito en hospitalización reciente. Se ajusta tratamiento ATB a imipenem, amikacina. Se toma CAET y PCR para panel viral, bacteriológico y, en acuerdo con hematólogo tratante, muestras para PCR CMV, HHS6, EBV y parvovirus B19.

Hematológico: paciente con TPH marzo 2024, usuaria de inmunosupresores. Evaluada por su equipo tratante, se realiza hoy 12/09 mielograma para evaluar reactivación de enfermedad.

Medio interno: inicia HFAV a las 22:00 del 11/09, con escasa respuesta. Sin otras alteraciones hidroelectrolíticas o necesidad de soporte renal. Por hipoglucemia inicia aporte de glucosa EV.

ESTADO ACTUAL.

Paciente de extrema gravedad, se mantiene con PA límite con uso de noradrenalina, adrenalina y vasopresina en dosis altas. Taquicardia persistente, presenta mottling score 4 puntos y llene capilar mayor a 5 segundos.

EXAMEN FÍSICO:

SV 09:00 PA 114/37, PAM 61, FC 137. VMI FiO2 85%, PEEP 8, PS 10, FR 26, Vt 400

SAS 1.

CRT > 5 segundos.

Mottling score 4 puntos, extremidades frías.

Pulmonar: MP (+), crépitos base izquierda.

EEII: sin edema.

Lab 12/09/2024

Hto 26.1%, Hb 8.5, GB 3580, RAN 3100, plaquetas 10.000

ELP Na 143, K 4.25, CI 113

GSA pH 7.249, PO2 76.1, PCO2 41, HCO3 17.5, EB (-) 9.7, Sat 93.1%, DeltaCO2 13.4, láctico 8.4 mmol/L

Albúmina 1.7, BiliT 3.91, BiliD 3.63, FA 119, GGT 94, GOT 57, GPT 29, Calcio 7.6,

Creatinina 1.13, BUN 21.5, Fósforo 4.7,

Glucosa 17, LDH 293, PCR 433.5 mg/L

Fecha Epicrisis : 12/09/2024 23:24

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 12-09-2024 23:24:37

Página 3 de 4

INR 2.63, TTPA 54.1

Microbiología.

HC 10/09: E. coli resistente ampicilina/sulbactam, cefazolina, Ciprofloxacino, tazonam, cotrimoxazol.

Urocultivo 10/09: Polimicrobiano

PCR COVID19 11/09 negativo

Panel viral 11/09: Metapneumovirus

CAET (SU) 11/09: E. coli escaso desarrollo.

CAET (UPC) 11/09: BGN escasa cantidad.

Panel viral por PCR 11/09: Rhinovirus.

Panel respiratorio bacteriano por PCR 11/09: Negativo

Imágenes

TC TAP 10/09: Extenso foco de condensación de aspecto neumónico en la llingula con áreas excavadas en su interior.

Evolucion UCI pm:

APACHE II (12/09) 31 puntos

SOFA (12/09) 16 puntos.

DIAGNÓSTICOS ACTUALES

1) Shock septico refractario.

a) Foco de neumopatía en llingula.

b) Bacteremia por E. coli.

c) Panel viral (+) Metapneumovirus

d) PCR Viral CAET (+) Rhinovirus.

e) HFAV Fi 11/09 22:30

2) NFAR de alto riesgo

3) FOM.

a) Disfuncion circulatoria persistente

b) Insuficiencia respiratoria catastrofica

c) Coagulopatía; plaquetopenia

d) Falla hepatica aguda; hipoglicemia recurrente

e) Insuficiencia renal aguda oligurica

4) Antecedentes: LLA Phi (+), TPH marzo 2024.

Pcte de extra gravedad, pronostico ominoso en el plazo inmediato

Cursando con shock septico refractario, con disfuncion circulatoria persistente, alteracion fija del llene capilar, moteado difuso, asociado a hiperlactatemia en aumento, hipotensa pese a dosis elevadas de drogas vasoactivas: noradrenalina-adrenalina y vasopresina. Fue conectada a HFAV anoche, tras 4-6 hrs, no se logran elementos de respuesta, lo cual se mantuvo tras 12 horas, considerandose como futilidad el mantener conexion a dicha terapia (conversado con jefatura)

En forma concomitante, evoluciona con deterioro gasometrico severo, PAFI<100, pese a parametros protectores, sedoanalgesia profunda y bloqueo neuromuscular y prono.

Oligoanurica durante la madrugada a la fecha, pero sin criterios para dialisis de agudo.

Coaguloatía en progresion, plaquetopenia severa.

Hiperbilirrubinemia directa en aumento, hipoglicemias frecuentes pese aportes de glucosado.

Evaluacion de hematología, se anexa comentario:

Paciente extremadamente grave en contexto de shock septico foco pulmonar en paciente inmunosuprimida, sin evidencia de recaida de leucemia aguda, probable nueva reactivacion de virus mielotropos. se ha dado manejo activo por equipo de UCI hasta el momento, la proporcionalidad del manejo debe ser definida en el contexto de la respuesta o refractariedad al manejo del shock por equipo de intensivo. se mantiene en seguimiento de caso

En suma, pcte de extrema gravedad, disfuncion circulatoria persistente en falla multiorganica, sin respuesta a medidas de

Fecha Epicrisis : 12/09/2024 23:24

Página 3 de 4

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:30

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 12-09-2024 23:24:37

Página 4 de 4

salvataje, en este caso HFAV. Caso comentado a jefatura, se acuerda adecuación de esfuerzo terapéutico.
No subir dosis de drogas vasoactivas, no RCP en caso de PCR
Se optimiza medidas de confort, acompañamiento familiar, sed o analgesia y regreso a posición de supino.

Evolución noche

Pcte con evolución catastrófica.

Presenta cese de actividad cardíaca a las 23:15 hrs

Previamente se avisa telefónicamente a padre sobre condición de riesgo vital inminente

Se constata fallecimiento a las 23:15 hrs

Dra. Medina.-

Diagnóstico de Egreso

Shock séptico -

Shock séptico - falla orgánica múltiple

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

en epicrisis

Plan Post Alta

en epicrisis

Indicaciones

Tipo de Reposo :

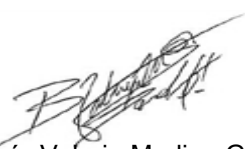
Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Andrés Vargas Silva
Becado/Residente


María Valeria Medina Gatica
Médico Tratante (Staff)